

ชื่อกิจกรรม "การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) : Type 2 diabetes"

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา เรียงคำ วิทยาการ

ผู้ช่วยอาจารย์ปิโยรส เกษตรกาลาม์ ผู้ลิขิต

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) : Type 2 diabetes" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา เรียงคำ วิทยาการในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ณ ห้อง ๙๐๑ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การสอน "การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) : Type 2 diabetes" เป็นการจัดการการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการการใช้ยาสมเหตุผล โดยมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ อภิปราย และเข้าใจในหลักการการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถนำสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพมาจัดการประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับกรณีศึกษาได้ ซึ่งการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงเนื้อหาหลัก ๒ ส่วน ดังนี้

๑) ๑๐ ขั้นตอนและกรอบความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประกอบด้วย

๑. ข้อบ่งชี้ (Indication) ใช้ยาเมื่อมีความจำเป็น (เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ)

๒. ประสิทธิภาพ (Efficacy) ยานั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยอาจพิจารณาจากกลไก การออกฤทธิ์ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนเพียงพอ

๓. ความเสี่ยง (Risk) คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก มีประโยชน์มากกว่าโทษ และไม่มีข้อห้ามใช้ผู้ป่วย

๔. ค่าใช้จ่าย (Cost) ใช้ยาอย่างเพียงพอและคุ้มค่า

๕. องค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น (Other considerations) รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง รับผิดชอบและใช้ยาอย่างเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานทางวิชาการ

๖. ขนาดยา (Dose) ใช้ยาถูกขนาด

๗. วิธีให้ยา (Method of administration)

๘. ความถี่ในการให้ยา

๙. ระยะเวลาในการให้ยา (Duration of treatment)

๑๐. การยอมรับของผู้ป่วยและความสะดวกในการใช้ยา (Patient compliance)

๒) ๑๐ สมรรถนะในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย

The consultation

๑. Assess the patient: History, Side effect, Adherence

๒. Consider the options: Lifestyle modification, Comorbidity

๓. Reach a shared decision: Communication, Nonjudgement (การให้ข้อมูลต่างๆที่เพียงพอทำให้ผู้ป่วยสามารถที่จะร่วมในการตัดสินใจได้)

๔. Administer safely: Risk of adverse events, กรอบบัญชียาหลัก

๕. Provide information: Health literacy

๖. Monitor and review: Clinical improvement, Psychosocial problems

Prescribing Governance (มีการติดตามประเมิน Clinical improvement เช่น HbA1C ค่าระดับน้ำตาลในเลือด ค่าการทำงานของไต หรือมีประเด็นปัญหาทางจิตสังคมที่เป็นส่วนเสริมหรืออุปสรรคในการใช้ยาหรือไม่)

๗. Prescribe safely: บริหารยาอย่างปลอดภัย 7R/10R

๘. Prescribe professionally: กฎหมายวิชาชีพ เวชจริยศาสตร์ (การสั่งจ่ายยาของ NP)

๙. Improve prescribing practice: Audit and feedback, Reflective (ให้นักศึกษาประเมินตนเองในการบริหารยาของตนเองทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ต้องปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค)

๑๐. Prescribe as part of a team: Interprofessional Practice (พัฒนาความรู้ของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้สามารถไปทำงาน อภิปรายกับทีมสุขภาพได้)

จาก Type 2 Diabetes Pharmacotherapy Updated 2023 Treatment Algorithm ได้มุ่งเน้นเรื่อง lifestyle ของผู้ป่วย การให้ความรู้ (Education support) และการจัดการตนเอง (Self-management) จะช่วยให้ผู้ป่วยปรับพฤติกรรม และควบคุมโรคได้ดีขึ้น และยังเพิ่มเติมในเรื่องบริบทของผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เช่น การมีสวนสาธารณะ การเข้าถึงแหล่งอาหาร เป็นต้น

ในประเด็นเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปัจจุบันยากกลุ่มแรกของเบาหวานชนิดที่ 2 คือกลุ่ม Biguanide ซึ่งแต่เดิมการใช้ยาจะเป็นกลุ่ม Biguanide และกลุ่ม Sulfonylurea โดยการจ่ายยาจะเริ่มที่ ยา ๑ ชนิดแล้วติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ถ้ายังไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเริ่มยากกลุ่มที่ ๒ ซึ่งการจะเลือกใช้ยาในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานต้องคำนึงถึงโรคร่วมของผู้ป่วย (โดยเฉพาะ Atherosclerosis, Cardiovascular disease, Heart failure และ Chronic kidney disease) โดยแนะนำให้ใช้ยากกลุ่ม GLP-1 RA (ยาฉีด) หรือกลุ่ม SGLT 2i (การเลือกใช้จะพิจารณาถึงประสิทธิภาพเนื่องจากราคาค่อนข้างแพง) ในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม Atherosclerosis และ Cardiovascular disease คล้ายคลึงกับผู้ป่วยที่มีโรคร่วม Heart failure แนะนำให้ใช้ยากกลุ่ม SGLT 2i และควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม TZDs เนื่องจากผลข้างเคียงของยาที่สำคัญคือการกักน้ำกลับ (water retention) ส่งผลให้มีน้ำเกิน การไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย และในผู้ป่วยที่มีโรคร่วม Chronic kidney disease แนะนำให้ใช้ยากกลุ่ม ACEi/ARB หรือกลุ่ม SGLT 2i

นอกจากโรคร่วมแล้ว ยังต้องพิจารณากลุ่มยาที่มีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด และการลดน้ำหนัก ซึ่งกลุ่มยา GLP-1 RA (ยาฉีด) มีประโยชน์ในการลดน้ำหนักร่วมด้วย หรือยารับประทานเช่น Metformin หรือยากกลุ่ม SGLT 2i, Sulfonylurea, TZDs หรือ DPP-4i (ยากกลุ่มนี้ค่อนข้างแพงแต่อาจจะช่วยเพิ่ม Medical adherence เนื่องจากรับประทานวันละครั้ง) และยังต้องประเมินราคาและการเข้าถึงยาร่วม

ด้วย เช่น กลุ่ม Sulfonylurea, TZDs, Insulin (กลุ่มยาที่กระตุ้นการหลั่ง insulin อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้)

การใช้อยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ผลข้างเคียงที่สำคัญคือ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia) ซึ่งอาจจะเลือกใช้อยากลุ่ม DPP-4i, GLP-1 RA, SGLT 2i และ TZDs แทนเนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำน้อย จากกลไกของยาจะไปกระตุ้นการหลั่ง insulin ในปริมาณไม่มาก โดยเฉพาะ SGLT 2i จะเพิ่มการขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะเป็นหลัก

ประเด็นต่อมาที่ต้องระวัง คือ การใช้ยาร่วมกันหลายขนาน (Polypharmacy) ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการใช้อยากลุ่ม Sulfonylurea ร่วมกับ Beta-blocker จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด severe hypoglycemia ส่งผลให้ผู้ป่วยอาจต้องเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล หรือพบ Serious Adverse Events เช่น death, macrovascular complications, cardiovascular death, dementia หรือ falls and fractures เป็นต้น

การสอน “การใช้ยาสมเหตุผล” โดยประยุกต์กรณีศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นการจัดการการเรียนรู้การสอนที่จะต้องนำกรอบแนวคิด RDU มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลข้างเคียงของยา medical adherence เหตุผลในการใช้ยา การหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้บรรลุเป้าหมายแต่ละราย ไม่ตัดสินผู้ป่วยหากมีพฤติกรรมในการกินยาไม่เหมาะสมโดยจะต้องสอบถามเหตุผลก่อนเสมอ รวมถึงการเข้าถึงยานอกบัญชียาหลัก ในกรณียาที่ผู้ป่วยใช้ไม่สามารถควบคุมอาการหรือระดับน้ำตาลในเลือดในอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ การคำนึงถึง Health literacy หรือ Psychosocial Problems ของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของผู้ป่วย และจัดการได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use: RDU) : Type 2 diabetes" ด้านการศึกษา คือ เป็นการบูรณาการเนื้อหาหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในหลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มีการคิดวิเคราะห์ อภิปราย สามารถนำสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพมาจัดการประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลกับกรณีศึกษา ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้เมื่อขึ้นฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วย

.....

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑. รศ.ดร.วิมลรัตน์	ภู่วรรุฒิพานิช
๒. ผศ.ดร. วารุณี	พลิกบัว
๓. รศ.ดร.ดวงรัตน์	วัฒนกิจไกรเลิศ
๔. รศ.ดร.อัจฉริยา	พ่วงแก้ว
๕. ผศ.ดร.ศรัณยา	โสมิตะมงคล
๖. ผศ. จงกลวรรณ	มุสิกทอง
๗. ผศ.ดร.ศรินรัตน์	ศรีประสงค์
๘. ผศ.ดร.พิจิตรา	เล็กดำรงกุล
๙. อ.ดร. ชลธิรา	เรียงคำ
๑๐. ผขอ.ณัฏยา	ประหา
๑๑. ผขอ.วราภรณ์	พานิชปฐม
๑๒. ผขอ.ประพัฒน์สินี	ประไพวงษ์
๑๓. ผขอ.สิริกาญจน์	หาญรบ
๑๔. ผขอ.ปิโยรส	เกษตรกาลาม์

ผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้
ในหัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล: โรคเบาหวาน”
โดย อาจารย์ ดร.ชลธิรา เรียงคำ
วัน พุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น
ห้องประชุม ๙๐๑

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๔ ราย ตอบแบบประเมิน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๒

๑) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสวนา

หัวข้อในการประเมิน	จำนวนคำตอบ (ราย/ ร้อยละ)			
	มาก	ปานกลาง	น้อย	ไม่ตอบ
ผู้นำสามารถนำประเด็นเสวนาได้ชัดเจน	๕ (๑๐๐)	-	-	-
ผู้นำเสวนาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย	๕ (๑๐๐)	-	-	-
รูปแบบ และวิธีการนำเสวนาทำให้มีการวิเคราะห์ปัญหาได้ทั่วถึง	๕ (๑๐๐)	-	-	-
มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้	๕ (๑๐๐)	-	-	-
มีโอกาสดแสดงความคิดเห็นและซักถามได้	๕ (๑๐๐)	-	-	-
หัวข้อเสวนาน่าสนใจ	๕ (๑๐๐)	-	-	-

๒) โดยสรุป ท่านเห็นว่าการเสวนาครั้งนี้อยู่ในระดับใด

ดีมาก ๕ ราย (ร้อยละ ๑๐๐)

ดี -

ปานกลาง -

ควรปรับปรุง -

๓) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

-ไม่มี-